



SKRINING RISIKO BUNUH DIRI DAN MELUKAI DIRI SENDIRI

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
117.2/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2026

No. Revisi
00

Halaman
1 / 1

STANDART PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 11 Februari 2026	Ditetapkan Oleh: Direktur RS. Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep
Pengertian	Prosedur pemeriksaan singkat untuk mengidentifikasi apakah seseorang berisiko memiliki pikiran, niat atau kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.	
Tujuan	1. Mengenali tanda-tanda peringatan dan kemunculan ide bunuh diri 2. Mengetahui apakah seseorang berada pada risiko rendah, sedang, atau tinggi	
Kebijakan	Peraturan Direktur Pedoman Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 935.5/RSPHS/I-PER/DIR/XI/2025 tentang Pedoman Pelayanan dan Asuhan Pasien	
Prosedur	1. Langkah – langkah : a. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan atau nomer rekam medis). b. Jelaskan tujuan dan langkah-langkah prosedur. c. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah. d. Lakukan skrining bunuh diri dengan mengajukan beberapa pertanyaan yaitu : a) Dalam beberapa minggu terakhir, apakah anda berhadap anda mati? b) Dalam beberapa minggu terakhir, apakah anda merasa bahwa anda atau keluarga anda akan lebih baik jika anda meninggal dunia? c) Dalam seminggu terakhir, apakah anda pernah berpikir untuk bunuh diri? d) Pernahkah anda mencoba bunuh diri? Jika ya: Bagaimana caranya? Kapan? Jika klien menjawab “Ya” untuk salah satu pertanyaan diatas, ajukan pertanyaan ketajaman berikut : e) Apakah anda sedang berpikir untuk bunuh diri saat ini? Jika ya, mohon jelaskan Penilaian • Jika klien menjawab “ Tidak” untuk semua pertanyaan 1 hingga 4, skrining selesai dan tidak perlu mengajukan pertanyaan #5. Tidak diperlukan intervensi, meskipun pertimbangan klinis selalu dapat mengesampingkan hasil skrining negatif. • Jika klien menjawab “Ya” untuk salah satu pertanyaan 1 hingga 4, atau menolak untuk menjawab, mereka dianggap hasil skrining positif, dan pertanyaan #5 harus diajukan untuk menilai tingkat keparahan risiko bunuh diri. • Jika klien menjawab “Ya” untuk pertanyaan #5, ini menunjukkan hasil skrining positif akut dengan risiko yang mengancam. Klien memerlukan evaluasi segera untuk keselamatan dan kesehatan mentalnya. Klien tidak boleh meninggalkan ruangan sampai mereka dievaluasi keselamatannya oleh penyedia layanan kesehatan. Mereka	

	harus tetap berada di area yang terus-menerus diawasi, semua benda berbahaya harus dikeluarkan dari ruangan, dan penyedia layanan kesehatan harus segera diberitahu • Jika klien menjawab “Tidak” untuk pertanyaan #5, ini menunjukkan hasil skrining positif non akut dengan potensi risiko yang teridentifikasi. Klien memerlukan penilaian keselamatan bunuh diri singkat untuk menentukan apakah evaluasi kesehatan mental lengkap diperlukan. Penyedia layanan kesehatan harus diberitahu.
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap (IRNA) 2. Instalasi Gawat Darurat (IGD) 3. Intensive Care Unit (ICU) 4. Maternitas 5. Neonatologi 6. Neonatus Intensive Care Unit (NICU) 7. Instalasi Rawat Jalan (IRJA)